ICS 11.020
C 05

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.13—2013

# 针灸技术操作规范
# 第 13 部分:芒针

**Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—**
**Part 13:Awn needle**

2013-12-31 发布 2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

# 前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为以下22部分：

——第1部分：艾灸；
——第2部分：头针；
——第3部分：耳针；
——第4部分：三棱针；
——第5部分：拔罐；
——第6部分：穴位注射；
——第7部分：皮肤针；
——第8部分：皮内针；
——第9部分：穴位敷贴；
——第10部分：穴位埋线；
——第11部分：电针；
——第12部分：火针；
——第13部分：芒针；
——第14部分：鍉针；
——第15部分：眼针；
——第16部分：腹针；
——第17部分：鼻针；
——第18部分：口唇针；
——第19部分：腕踝针；
——第20部分：毫针基本刺法；
——第21部分：毫针基本手法；
——第22部分：刮痧。

本部分为GB/T 21709的第13部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本部分起草单位：天津中医药大学第一附属医院。

本部分主要起草人：杨兆钢、杨铭、牛红月、蔡斐、韩力。

本部分参加起草人：高淑红、于涛、张继庆、杜宇征、吴敬、曹锐、张晓彤、刘涛、王海荣、张旸、聂鹏坤。

# 针灸技术操作规范
# 第13部分:芒针

## 1 范围

GB/T 21709的本部分规定了芒针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本部分适用于芒针技术操作。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15982—1995 医院消毒卫生标准

GB/T 21709.20—2009 针灸技术操作规范 第20部分:毫针基本刺法

GB/T 21709.21—2013 针灸技术操作规范 第21部分:毫针基本手法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**芒针 awn needle**

针灸工具的一种,由古代九针之一的长针演变而来,因针体细长,形如麦芒,故称为芒针。

## 4 操作步骤与要求

### 4.1 施术前准备

#### 4.1.1 针具选择

根据病情需要和操作部位选择不同型号芒针。所选择的芒针针体应光滑、无锈蚀,针尖宜端正不偏,光洁度高,尖中带圆,长度在100 mm～200 mm之间。(参见附录A)

#### 4.1.2 部位选择

根据病情选取适当的施术部位。

#### 4.1.3 体位选择

选择医者便于操作、患者舒适的施术体位。

#### 4.1.4 环境要求

注意环境清洁卫生,避免污染。

#### 4.1.5 消毒

##### 4.1.5.1 针具消毒

选择高压消毒法。可选择一次性芒针。

##### 4.1.5.2 部位消毒

可用75%医用乙醇或碘伏在施术部位消毒，消毒操作应符合GB 15982—1995的规定。

##### 4.1.5.3 医者消毒

医者双手用肥皂水清洗干净，再用75%医用乙醇擦拭，消毒操作应符合GB 15982—1995的规定。

### 4.2 施术方法

#### 4.2.1 进针法

##### 4.2.1.1 基本方法

医者刺手、押手紧密配合。刺手持针柄，押手持针体。刺手拇、食、中指第一节挟持针柄的稍下方，用无名指抵住针体，以使针体和穴位表面保持一定角度；押手以无名指及小指自然弯曲，并以指甲贴于穴旁，小指尖端压住穴旁之皮肤，以食、拇、中三指挟持针体，使针体首先通过拇指与食指之第二关节横纹之间，再通过食指与中指第一关节横纹之间进入皮肤。利用刺手的指力和腕力，压捻结合，针尖垂直迅速刺过表皮，进入皮下后，刺手边小幅度(180°～360°)高频率(>100次/min)捻转边进针，可配合提插，押手辅助把握针尖方向，达到一定深度，针体保留在皮肤外2 cm以上。得气后可施以捻转、提插、捻转提插相结合的补泻手法，也可结合使用其他补泻手法。留针时间、疗程、疗次参见附录B。

##### 4.2.1.2 刺法

###### 4.2.1.2.1 直刺法

芒针垂直刺入穴位，直达人体深部。一般适用于脘腹、臀部、腰背及肌肉丰厚处，适应症参见附录C。

###### 4.2.1.2.2 斜刺法

进针时，针体与皮肤约呈45°的角倾斜刺入。一般适用于四肢内外侧、前后侧躯干、头颈项部、面部的穴位，适应症参见附录C。

###### 4.2.1.2.3 平刺法

进针时，针体与皮肤呈小于15°的角刺入。一般适用于头背部皮肤浅薄的穴位，适应症参见附录C。

###### 4.2.1.2.4 弯刺法

进针到一定深度后，刺手、押手紧密配合，并根据穴位所在部位不同的解剖特点，相应地改变押手所掌握的针刺角度，利用针体的自然弹性，按压针柄，使针自然弯曲，变换针尖的方向，将针刺入相应部(穴)位，达到要求的针刺麻胀感后立即出针。一般适用于直刺和斜刺均不能达到的特殊穴位，如天突穴、面部透穴等，适应症参见附录C。

#### 4.2.2 出针法

因为芒针进针较深，故出针时应先以左手拇指、食指或食指、中指固定被刺腧穴周围皮肤，右手轻柔缓慢地进行捻转抽提针体，将针尖退至皮下，停留 3 s～5 s 再轻轻出针。出针后用镊子持消毒干棉球按压针孔数秒，若有出血现象延长按压时间。

## 5 注意事项

5.1 进针后轻捻缓进。针刺过程中如遇阻力不可强行进针，应立即退针改变方向后再进针。

5.2 进出针时，可配合呼吸、开阖补泻。若出现局部肿胀，提示皮下出血，应先局部冷敷止血，24 h 后可热敷以促进瘀血的消散；若出针后其酸胀疼痛感不减，且遗留时间较长，提示系手法过重、刺激过强所致，可辅助按摩或热敷。

5.3 选穴宜少而精。

5.4 体质虚弱、消瘦及有晕针史的患者应慎用；患者精神紧张、大汗后、劳累后或饥饿时亦不适宜接受本刺法。

5.5 注意晕针的发生。如发生晕针，处理方法见附录 D。

5.6 注意滞针和弯针的发生。如发生滞针和弯针的现象，处理方法见附录 D。

5.7 严重精神病患者应慎用。

## 6 禁忌

6.1 孕妇禁用。

6.2 自发性出血者禁用。

6.3 针刺部位有血管怒张、瘢痕、伤口、严重溃疡及肿物者禁用。

# 附　录　A
（资料性附录）
# 芒针针具的形状和材质

## A.1　芒针的结构

芒针的结构与毫针相同，可分五个部分：

a）　针尖（针芒）：针的前端锋锐部分，应圆利，不宜太锐。

b）　针体：针尖至针柄之间。针体应光滑并粗细均匀。

c）　针根：针体与针柄交界之处，以牢固为准，此部位易折断。

d）　针柄：在针体之后部分，一般用铜丝绕成，呈圆筒状，较毫针略长，是执针着力的地方，要牢固，以防脱落。

e）　针尾：柄的末梢部分。

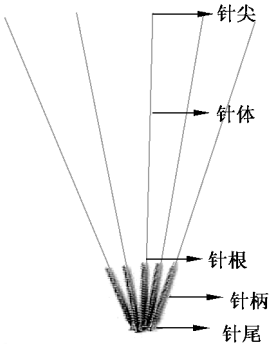


图 A.1　芒针的结构

## A.2　芒针的材质

现代的芒针，用银质、铜质或不锈钢丝制成。临床中，以弹性、韧性较好的细不锈钢丝制成的芒针为常用。

## A.3　芒针的长度

芒针的长短、粗细规格主要是指针体而言。常用芒针的针体长度为 100 mm～200 mm，29 号（直径 0.34 mm）、30 号（直径 0.32 mm）、31 号（直径 0.30 mm）、32 号（直径 0.28 mm）粗细的芒针用途较多。200 mm 以上的芒针，一般临床上应用不多。

# 附　录　B
（资料性附录）
## 芒针留针时间、疗程、疗次

芒针根据病情、选穴和治疗体位不同，留针时间有所不同。芒针弯刺法一般不留针，得气后施手法操作达到一定的刺激量后即刻出针；其余刺法达到一定的针刺感应后可不留针，或留针 15 min～30 min。一般每日 1 次或隔日 1 次，12 次～14 次为一疗程。2 个疗程之间，可休息 3 d～5 d。

# 附　录　C
（资料性附录）
芒针适应症

## C.1　神经系统疾病

瘫痪、脑血管病后遗症、神经痛、神经根炎、多发性神经炎。神经痛主要包括：坐骨神经痛、三叉神经痛、偏头痛、神经性头痛、面神经麻痹、面肌痉挛等。

## C.2　运动系统疾病

关节痛、软组织损伤、肩关节周围炎、急性腰扭伤、梨状肌综合征、腰椎间盘突出症、肋软骨炎、膝骨关节炎等。

## C.3　消化系统疾病

胃炎、胃下垂。内脏的各种痉挛性疼痛包括消化性溃疡、胃痉挛、胃及十二指肠溃疡、胃神经官能症、胆囊炎、胆石症等。

## C.4　呼吸系统疾病

哮喘、肺气肿、支气管炎等。

## C.5　泌尿生殖系统疾病

前列腺肥大和前列腺炎、脊髓损伤导致的尿潴留、尿失禁、泌尿系结石、子宫脱垂、月经紊乱、不孕不育症、阴痒、功能性阳痿等。

## C.6　免疫系统疾病

风湿、类风湿性关节炎等。

## C.7　其他疾病

下肢静脉曲张、咽异感症、癫痫、抑郁症、精神分裂症等。

# 附　录　D
（规范性附录）
## 芒针晕针、滞针和弯针处理方法

**D.1**　若发生晕针应立即停止治疗，将针全部拔出，使患者呈头低脚高卧位，必要时可饮温开水或温糖水或掐水沟穴等处理。

**D.2**　因病人精神紧张或局部肌肉痉挛而引起滞针时，可稍停片刻并于滞针处附近进行循按或叩弹针柄，或于滞针处附近选一、二穴用毫针针刺。因针体与肌纤维缠绕过紧者，可向相反方向退转，并左右捻转，使之松解，即可消除滞针。

**D.3**　在施术过程中遇到因病人体位突然改变而致弯针或滞针时，应先纠正体位，切勿强力外拽及提插捻转，应将针缓慢退出。如针体弯曲角度较大，应轻微摇动针体，顺着弯曲方向退出。如针体弯曲不只一处，应视针柄扭转倾斜方向，缓缓分段退出。